



DBT

MATERIAL DE APOIO · AULA 08 DE 12

A relação terapêutica e comportamentos que interferem na terapia

Como a DBT entende a relação terapêutica como uma tensão constante entre aceitação e mudança, e como nomear, priorizar e manejar os comportamentos — da pessoa participante e da própria profissional — que interferem no tratamento.

DESCOMPLICANDO A DBT

Quem conduz a formação

Doze encontros ao vivo, aos sábados, para sair da leitura sobre DBT e chegar na condução da sessão — da teoria biossocial ao manejo de crise, com o pé na prática clínica.



IDEALIZADOR · PROFESSOR

Júlio Gonçalves



IDEALIZADORA · PROFESSORA

Andressa Juliana

Este material acompanha o encontro

As últimas páginas são preenchíveis: marque o checklist, responda as perguntas de revisão e guarde suas anotações no próprio arquivo. Salve depois de preencher.

O ESSENCIAL

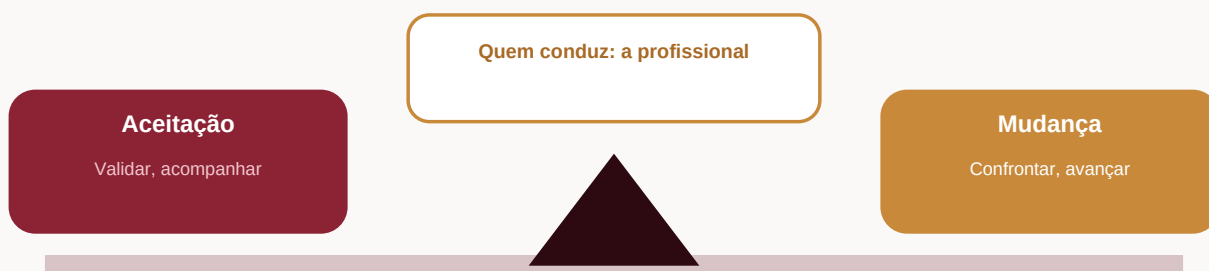
- **A relação terapêutica em DBT é pensada como uma tensão permanente entre aceitação e mudança** — nunca resolvida de vez, sempre reequilibrada sessão a sessão.
- **O modelo é transacional:** o que a profissional faz afeta imediatamente os pensamentos, emoções e comportamentos da pessoa participante, e vice-versa — nenhum impasse é só do paciente ou só da terapeuta.
- **Comportamentos que interferem na terapia se definem pela função, não pela forma.** O que importa é se reduzem o desconforto a curto prazo às custas do progresso — e isso vale tanto para quem é atendido quanto para quem atende.
- **A hierarquia de alvos prioriza o que ameaça destruir a terapia** — faltas recorrentes, inadimplência, rupturas graves de aliança — antes das metas de vida.
- **Estratégias de comprometimento preparam o engajamento antes de qualquer ferramenta ser introduzida**, e podem ser usadas de novo sempre que o compromisso enfraquecer.

01 A relação terapêutica como tensão dialética

A terapia comportamental dialética trata a relação terapêutica como uma tensão eterna entre aceitação e mudança — não um equilíbrio alcançado uma vez e mantido, mas um ajuste constante. Andressa Juliana usou duas metáforas para essa dinâmica: a **gangorra**, que se desequilibra sempre que um dos lados avança ou recua demais, e a **dança de salão**, em que a postura de aceitação acompanha o ritmo do parceiro, mas é a profissional quem conduz tecnicamente o passo.

A responsabilidade por restaurar o equilíbrio — sem deixar a pessoa participante “sair da pista” — é da profissional, não algo que se espera que aconteça sozinho (Linehan, 1993). A postura de aceitação acompanha; a condução técnica garante que o processo continue avançando.

FIGURA 1 · A GANGORRA ENTRE ACEITAÇÃO E MUDANÇA



Nenhum dos dois polos vence — a profissional é quem redistribui o peso para a gangorra não tombar.

02 O modelo transacional, na prática

Olhar a relação como transação significa que as ações de uma parte afetam imediatamente os pensamentos, emoções e comportamentos da outra — evitando ver o impasse como um problema isolado de quem é atendido.

Essa perspectiva reduz a autocrítica excessiva da profissional e os julgamentos precipitados sobre a pessoa participante (Linehan, 1993).

Andressa Juliana ilustrou com um cenário comum: a pessoa participante muda de assunto assim que recebe uma proposta de intervenção para a angústia emocional que estava sentindo. O mecanismo por trás é o **reforçamento negativo** — a retirada do estímulo aversivo (a proposta desconfortável) reforça o desvio de foco, uma estratégia que a pessoa já aprendeu a usar em outros contextos da vida. A tarefa da profissional é estar atenta a essa dinâmica no momento em que ela acontece, em vez de tratá-la como um detalhe isolado da sessão.

03 Dois estilos de comunicação

A DBT descreve dois estilos de comunicação complementares. A **comunicação recíproca** é o padrão: afeto, genuinidade e responsividade, usada principalmente para construir vínculo e nos momentos de vergonha intensa ou sensibilidade extrema à validação. A **comunicação irreverente** — inspirada no estilo da própria Marsha Linehan — é mais desafiadora de executar e depende da personalidade de quem atende; seu objetivo é sacudir a pessoa participante e tirá-la de posturas polarizadas.

O risco de confundir irreverência com hostilidade

O receio de adotar um tom direto e provocativo é real — e legítimo. A comunicação irreverente precisa ser baseada em afeto e dirigida estritamente ao melhor desenvolvimento da pessoa participante; agir com raiva, sarcasmo ou frieza diante de frustrações pontuais, como faltas e atrasos, é desaconselhado.

04 Na prática: o caso dos atrasos recorrentes

Andressa Juliana contrastou os dois estilos diante de um padrão concreto: atrasos recorrentes de vinte a trinta minutos. A comunicação recíproca entra primeiro, validando o sofrimento por trás do atraso; quando essa estratégia não muda o padrão, a comunicação irreverente confronta diretamente, de forma a surpreender e desequilibrar a pessoa participante o suficiente para romper a repetição.

A profissional deve evitar a **omissão eterna** — manter indefinidamente a mesma estratégia ineficiente só porque confrontar desgasta. Um exemplo citado em aula: estender o horário da sessão depois de um atraso, ou normalizar frases como “tá tudo bem” quando claramente não está, são formas de omissão que também contam como comportamento interferente — só que da parte da profissional. A saída é adotar regras claras desde o início, como limitar o tempo de espera.

05 O que são comportamentos interferentes: função, não forma

Comportamentos que interferem na terapia — tanto da pessoa participante quanto da profissional — se definem pela sua **função**, não pela sua forma: funcionam a curto prazo porque reduzem o desconforto, mas prejudicam o progresso e desgastam a relação (Linehan, 1993). Isso significa que o motivo pontual de um atraso importa menos do que o impacto que ele tem, de forma sustentada, sobre o tratamento — e é esse impacto que entra na análise da hierarquia de alvos.

A DBT equipara esses comportamentos ao conceito de resistência de abordagens psicodinâmicas, mas com um olhar mais detalhado, que inclui explicitamente os comportamentos da própria profissional, não só os da pessoa atendida.

A METÁFORA DO PRÉDIO EM CHAMAS

Marsha Linehan compara o processo terapêutico à travessia de um prédio em chamas (Linehan, 1993): tanto quem é atendido quanto quem atende sentem a relutância natural e o medo de enfrentar o sofrimento e o desconforto do caminho, e podem buscar portas de fuga mais fáceis. Comportamentos interferentes são esperados e comuns — enfrentar o desconhecido e o doloroso gera resistências legítimas, que precisam ser manejadas, não eliminadas por decreto.

06 Comportamentos interferentes comuns

Do lado de quem é atendido, os exemplos mais frequentes são fugas, faltas, atrasos, não conformidade com tarefas combinadas e hostilidade. Uma participante da turma perguntou, na aula, como intervir com alguém dominante e proífico no relato — equilibrar a escuta de conteúdos densos com a necessidade de uma condução mais diretiva é uma dificuldade real, e a orientação foi aguardar os passos metodológicos seguintes (nomear o comportamento, bloquear a fuga, analisar em cadeia) para aplicar a técnica adequada a cada caso.

Do lado da profissional, os comportamentos mais comuns são deixar de confrontar quando necessário, esquecer combinados, cometer quebras éticas e adotar uma **rigidez punitiva**. Essa rigidez aparece tipicamente quando a profissional está estressada e frustrada com a falta de progresso: torna-se inflexível, tenta controlar excessivamente a sessão ou se afasta afetivamente da pessoa participante — a perda do próprio equilíbrio dialético. O atendimento em DBT exige afeto genuíno, e é justamente essa afinidade com a demanda específica de cada caso que o pré-tratamento serve para avaliar.

07 Identificando a interferência: esgotamento e as três esferas de observação

Um sinal de alerta importante é o esgotamento da própria profissional — mensagens excessivas, pedidos constantes de remarcação — e o risco de ultrapassar os próprios limites para compensar falhas persistentes, assumindo um papel de heroína que tenta salvar o caso sozinha. Ignorar a própria regra de faltas consecutivas para “dar mais uma chance” é um exemplo típico desse movimento. Em certos casos, o desligamento da terapia é de fato a melhor consequência — inclusive para motivar a pessoa participante a se engajar de verdade num futuro processo, com outra profissional.

A identificação da interferência ganha precisão quando observada em três esferas:

- **Entre as sessões** — padrão de mensagens, pedidos de coaching fora de hora, remarcações
- **Durante o encontro** — respostas evasivas, ruminação, prolixidade, mudança de assunto
- **Nas próprias reações emocionais da profissional** — ansiedade pré-sessão, frustração recorrente, vontade de recuar quando seria a hora de resolver o problema

Cultivar autoconhecimento e atenção plena (mindfulness) é o que permite monitorar essas reações em tempo real, dentro da própria sessão — não só depois, em retrospecto.

08 Armadilhas comuns no manejo

Três armadilhas recorrentes: atribuir o comportamento à patologia borderline como se isso encerrasse a explicação, esperar que os sintomas desapareçam sozinhos, e internalizar o próprio desgaste como um defeito pessoal da profissional. Andressa Juliana relatou um caso pessoal: sentiu crescente indisposição ao receber coaching telefônico nos fins de semana, e a análise revelou que a pessoa em atendimento mandava mensagens sempre que via certos stories nas redes sociais, buscando compartilhar o sofrimento que aquilo despertava. A situação foi resolvida por diálogo direto e pelo estabelecimento de limites — sem romper o vínculo de forma

precipitada.

Avaliar o efeito real do comportamento é o que diferencia uma atitude secundária (uma piada autodepreciativa, por exemplo) de um verdadeiro obstáculo ao tratamento. Vale também perguntar por que é possível flexibilizar com certas pessoas e não com outras — essa pergunta, frequentemente, conecta o impasse da sessão aos mesmos problemas relacionais que motivaram a pessoa a buscar terapia, como a exigência de reassseguramento constante.

09 Hierarquia de alvos para comportamentos interferentes

Na formulação de caso, os comportamentos interferentes seguem uma hierarquia rigorosa de prioridade. No topo estão os que ameaçam destruir a terapia — faltas recorrentes, inadimplência, rupturas graves de aliança. Um exemplo citado em aula, de um caso externo: condutas terapêuticas inadequadas diante de ideação suicida levaram ao abandono do tratamento — uma ruptura grave que ilustra por que esses comportamentos vêm antes de qualquer outra coisa na hierarquia. Metas de vida e de trabalho ocupam posições secundárias, abaixo deles.

FIGURA 2 · A HIERARQUIA DE ALVOS, APLICADA AOS COMPORTAMENTOS INTERFERENTES



Antes de qualquer meta de vida, o que ameaça a continuidade do tratamento tem de ser resolvido primeiro.

10 Primeiros passos: nomear, bloquear a fuga, analisar em cadeia

A abordagem começa por nomear o comportamento em termos comportamentais específicos — não em rótulos vagos — e destacá-lo através da metáfora de uma **porta aberta num corredor**: parar ali, naquele ponto exato, e examinar a situação junto com a pessoa participante. Isso exige justificativa clara, observação fundamentada em fatos, descrição precisa e validação das dificuldades reais vividas — por exemplo, a rotina sobrecarregada de uma mãe —, sem que isso signifique validar o comportamento inadequado em si.

O passo seguinte é **bloquear a fuga**: vincular a ação interferente aos objetivos da própria pessoa participante — evitar o esgotamento da profissional, preservar as metas relacionais — e conduzir uma análise em cadeia breve para identificar os gatilhos. Um exemplo comum é o desabafo excessivo usado como forma de regulação emocional interpessoal. Queixas contínuas, ou o retorno a um padrão logo depois de um elogio, podem ser tentativas (nem sempre conscientes) de manter a terapia ativa por mais tempo — o que reforça a importância de esclarecer, desde o início, a duração prevista do tratamento.

11 Soluções no sistema, não correções forçadas

As soluções para comportamentos interferentes miram alterações no sistema e no contexto terapêutico global — não correções individuais impostas. Isso inclui ajustes de horário, flexibilização pontual de regras ou simplificação

de formulários, como o cartão diário, sempre sob um espírito de curiosidade e teste de hipóteses, não de punição. Técnicas de DBT e de outras abordagens podem ser empregadas independentemente de a pessoa já dominar as habilidades correspondentes.

12 Prevenção: limites claros desde o início

A melhor intervenção sobre um comportamento interferente é a que evita que ele se instale. Isso passa pela construção inicial da hierarquia de alvos, pela comunicação clara de limites — horários de coaching telefônico, política de atrasos e faltas — e pelo estabelecimento antecipado de regras de pagamento, que garantem a continuidade do tratamento sem que o tema vire uma negociação no meio de uma crise.

A identificação preventiva também passa por perguntar, já no início, sobre tratamentos anteriores — isso ajuda a mapear padrões problemáticos que tendem a se repetir na nova relação terapêutica. Demandas excessivas por coaching telefônico fora do horário combinado, ou uma dependência extrema em que a pessoa busca aprovação constante, costumam reaparecer se não foram identificadas e nomeadas antes.

13 Estabelecer limites é diferente de observá-los

Andressa Juliana separou dois movimentos que costumam ser confundidos: **estabelecer limites** é a definição prévia das regras — o enquadre combinado antes de qualquer crise. **Observar limites** é o monitoramento contínuo das próprias reações emocionais e do próprio desgaste, que indicam quando um limite está sendo testado ou ultrapassado. A responsabilidade sobre o limite é da profissional, nunca um rótulo pejorativo aplicado à pessoa participante.

Extensões temporárias de um limite são aceitáveis em crises agudas — mas o tratamento, fora dessas exceções, trata as pessoas participantes como adultos funcionais, capazes de lidar com dificuldades reais e com os próprios planos de crise já combinados.

14 Rupturas na aliança terapêutica

Rupturas afetam diretamente o afeto e a confiança na relação, e se manifestam por sarcasmo, retraimento ou ameaças de abandono do tratamento. Diante disso, a profissional precisa admitir falhas sem postura defensiva, validar a dor da pessoa participante e promover a reparação — demonstrando, na prática, que conflitos em relações humanas podem ser superados sem que isso signifique um rompimento definitivo.

15 A equipe de consultoria pessoal

A equipe de consultoria é parte estrutural do modelo, não um recurso opcional. Suas funções incluem o aprimoramento das habilidades da própria profissional, a sustentação da motivação, o fomento à compaixão, a garantia de fidelidade ao modelo da DBT, o monitoramento dos comportamentos interferentes num ambiente seguro, e a prevenção de divisões (splitting) dentro da própria equipe (Linehan, 1993).

16 Estratégias de comprometimento

Antes de introduzir qualquer ferramenta — cartão diário, plano de crise —, a DBT usa estratégias de comprometimento para engajar a pessoa participante de forma genuína. Várias vêm da literatura clássica de persuasão e influência social, incorporadas ao modelo de Linehan (1993):

- **Prós e contras** — explicitar juntos o que se ganha e o que se perde com o compromisso
- **Advogado do diabo** — a profissional levanta ela mesma os argumentos contrários ao compromisso, para que a pessoa os refute

- **Pé na porta** — começar com um pedido pequeno, que aumenta a chance de adesão a pedidos maiores depois (Freedman & Fraser, 1966)
- **Porta na cara** — abrir com um pedido amplo, para que o pedido real pareça menor por comparação (Cialdini et al., 1975)
- **Conexão com compromissos passados** — lembrar compromissos que a pessoa já cumpriu com sucesso antes
- **Liberdade de escolha associada à inevitabilidade das consequências** — a decisão é da pessoa, mas as consequências de cada escolha são reais e não negociáveis
- **Modelagem de pequenos progressos** — reconhecer e reforçar avanços parciais, não só o resultado final
- **Geração de esperança** — postura de treinador, que sustenta a crença de que a mudança é possível

17 Referências

- Cialdini, R. B., Vincent, J. E., Lewis, S. K., Catalan, J., Wheeler, D., & Darby, B. L. (1975). Reciprocal concessions procedure for inducing compliance: The door-in-the-face technique. *Journal of Personality and Social Psychology*, 31(2), 206–215.
- Freedman, J. L., & Fraser, S. C. (1966). Compliance without pressure: The foot-in-the-door technique. *Journal of Personality and Social Psychology*, 4(2), 195–202.
- Linehan, M. M. (1993). *Cognitive-behavioral treatment of borderline personality disorder*. Guilford Press.

NOTA DE MÉTODO

Resumo escrito a partir da transcrição do encontro, conduzido por Andressa Juliana, com intervenções pontuais de Júlio Gonçalves. As referências às técnicas de pé na porta e porta na cara foram complementadas com as fontes clássicas da literatura de persuasão que fundamentam essas estratégias de comprometimento, por não terem sido citadas com autor e ano no encontro. O nome da aluna que fez uma pergunta em aula foi omitido para preservar sua privacidade neste material público. Nenhum caso clínico real identificável foi usado nesta aula.

Levar para a prática

Marque conforme experimentar em sessão. O arquivo guarda o que você preencher.

- ☐ Identifiquei, nas últimas semanas, um comportamento meu que interfere na terapia — não só do paciente.
- ☐ Nomeei um comportamento interferente em termos específicos, sem rótulos vagos, e parei para examiná-lo com o paciente.
- ☐ Revisei a hierarquia de alvos de um caso, priorizando o que ameaça a continuidade da terapia antes das metas de vida.
- ☐ Usei a comunicação recíproca antes de considerar a irreverente, diante de um padrão repetido.
- ☐ Revi os limites combinados com um paciente — horários, faltas, pagamento — antes que um deles fosse testado.

Minhas anotações — o que levo para a clínica



Para revisar — resposta

Responda com suas palavras. O texto fica salvo no PDF.

- 01.** Uma pessoa muda de assunto toda vez que tu propõe uma intervenção para a angústia que ela relata. Isso é “resistência” dela, ou tem outra leitura?

- 02.** Tu reagiu com um comentário irônico quando um paciente chegou quarenta minutos atrasado pela terceira vez no mês. Isso foi comunicação irreverente?

- 03.** Um paciente falta à terceira sessão seguida e manda uma mensagem dizendo que “não adianta mais nada”. Onde isso entra na hierarquia de alvos, e o que vem primeiro?